맹장염과 급성 게실염, 응급 대응 가이드

맹장염(급성 충수염)과 급성 게실염 — 무엇이 다르고, 언제 응급실로 가야 하는지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

갑자기 시작된 복통, 무엇을 의심해야 할까요

맹장염과 게실염은 시간 싸움입니다 — 일찍 알아차리면 합병증을 막을 수 있습니다

⚠ 몇 시간 넘게 이어지는 복통

단순히 체한 것이 아니라 **수술이나 입원이 필요한 응급**일 수 있습니다.

두 병 모두 터질 수 있습니다

시간이 지나면 장이 터져 배 안 전체에 염증(복막염)이 번질 수 있습니다. 맹장염은 평생 **약 7%**가 겪습니다.

집에서는 구분이 어렵습니다

아픈 곳과 많이 생기는 나이가 다르지만, **진찰과 영상 검사(초음파·CT)**가 있어야 구분됩니다.

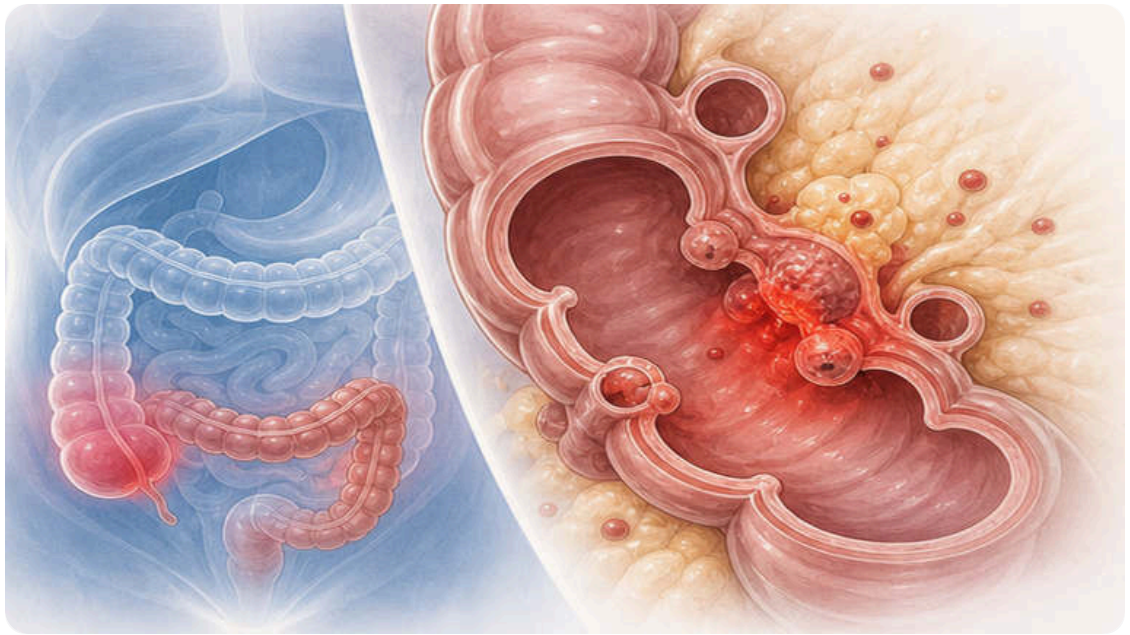


그림 · 왼쪽은 붉게 부은 맹장 끝(충수), 오른쪽은 대장 벽에 튀어나온 주머니(게실)의 염증입니다(설명용 그림).

Tip · 위험 신호를 알아 두면 응급실에 갈 때를 놓치지 않습니다.

근거 · 대한외과학회 · 대한대장항문학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

맹장염(급성 충수염) — 이렇게 진행합니다

맹장 끝에 달린 작은 관(충수)이 막히고 염증이 생겨 부풀어 오르는 병입니다

1

입구가 막힘

시작

대변 덩어리나 림프 조직이 커져 충수 입구가 막히고 점액이 고입니다.

2

배꼽 주변 통증

처음 몇 시간

세균이 늘며 염증이 시작되고, 처음에는 배꼽 주변이 막연히 아픕니다.

3

오른쪽 아랫배로 이동

4~12시간

통증이 오른쪽 아랫배로 옮겨 가 한 곳이 뚜렷하게 아파집니다.

4

터질 위험

24시간 이후

치료가 늦어질수록 충수가 터져 복막염으로 번질 위험이 크게 늘어납니다.

10~30대에 가장 흔합니다 그러나 어느 나이에나 생길 수 있고, 고령·소아는 증상이 약하게 나타나 장염처럼 보일 수 있습니다.

Tip · 통증이 옮겨 가는 모습은 맹장염의 대표적인 신호입니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · 광교바른내과 맹장염 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

급성 게실염 — 대장 벽 주머니에 생긴 염증

대장 벽의 약한 곳이 주머니처럼 튀어나온 것이 '게실'입니다

게실은 흔하고 대부분 증상이 없습니다

평생 모르고 지내기도 합니다. 입구가 막히고 세균이 늘면 **급성 염증**이 생깁니다.

한국인은 오른쪽이 흔합니다

서양인은 왼쪽이 흔하지만, 한국인은 **맹장 근처 오른쪽**에 많아 맹장염과 헷갈리기 쉽습니다.

위험 요인

나이가 많을수록 늘고, 기름진 식사·변비·비만이 위험 요인으로 알려져 있습니다.

합병증

터짐·고름주머니·장과 장 사이 샛길·장이 좁아짐으로 진행할 수 있어 **영상 검사**로 확인합니다.



그림 · 두 병 모두 아랫배 통증으로 올 수 있어 겉모습만으로는 구분이 어렵습니다(설명용 그림).

Tip · 오른쪽 아랫배가 아프다고 모두 맹장염은 아닙니다 — 진찰과 검사로 구분합니다.

근거 · 대한대장항문학회 · AGA 게실염 임상 업데이트 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

맹장염과 게실염, 이렇게 다릅니다

증상은 비슷해 보여도 아픈 곳과 많이 생기는 나이가 다릅니다

맹장염(급성 충수염)

오른쪽 아랫배 — 배꼽 주변에서 시작해 옮겨 갑니다.

- 많은 나이 — 10~30대
- 주요 증상 — 입맛 없음·메스꺼움·옮겨 가는 통증
- 치료 — 수술로 떼어 내는 것이 표준
- 늦어지면 복막염·전신 감염(패혈증) 위험

vs

급성 게실염

왼쪽(서양) 또는 오른쪽(한국) 아랫배가 아픕니다.

- 많은 나이 — 중장년 이상
- 주요 증상 — 한 곳 누르면 아픔·열·변비나 설사
- 치료 — 식사 조절, 가벼우면 항생제 없이 지켜보기도 함
- 합병증이 있으면 고름 빼기·수술을 고려

Tip · 한국인의 오른쪽 게실염은 맹장염과 위치가 겹쳐 영상 검사로 구분합니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · AGA 게실염 임상 업데이트 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

집에서 알아차릴 수 있는 여섯 가지 신호

한두 가지라도 해당되면 진료를 미루지 마세요

옮겨 가는 복통

배꼽 주변이 막연히 아프다가 4~12시간 뒤 오른쪽 아랫배로 옮겨 갑니다.

입맛 없음 · 메스꺼움

좋아하던 음식도 싫고 메스껍거나 토합니다. 체한 것과 달리 시간이 지나도 안 좋아집니다.

움직이면 더 아픔

걷거나 기침할 때, 발뒤꿈치로 바닥을 디딜 때 아랫배가 찌릿하면 배 안쪽이 자극된 신호입니다.

한 곳이 뚜렷하게 아픔

손가락 하나로 짚을 수 있는 곳이 아픕니다. 오른쪽 게실염도 맹장 근처에서 이렇게 아픕니다.

미열 → 고열

처음에는 37.5~38°C 미열로 시작해 38°C 넘게 오르면 염증이 진행했을 수 있습니다.

약을 먹어도 계속됨

장염약·복통약을 먹어도 좋아지지 않고 통증이 계속되면 같은 날 다시 진료를 받습니다.

Tip · 고령이나 어린이는 통증·열이 약해 장염처럼 보일 수 있으니 더 주의하세요.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · 광교바른내과 맹장염 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

배를 눌러 보는 확인은 의료진에게 맡기세요

집에서 반복해 누르며 확인하지 말고, 진료실에서 아래 순서로 확인합니다



그림 · 아픈 배를 스스로 거듭 누르지 말고, 멈춘 뒤 진찰을 받습니다.

1 진찰 의료진

아픈 곳을 누르고 뗄 때 통증이 더 심해지는지(복막 자극)를 의사가 확인합니다.

2 피검사 염증 수치

백혈구·염증 수치(CRP)가 올라 있는지 봅니다.

3 영상 검사 초음파·CT

맹장·게실의 염증과 터짐·고름주머니가 있는지 확인합니다.

4 치료 결정 외래·입원·수술

진찰·피검사·영상·증상 경과를 모아 치료 방법을 정합니다.

Tip · 반복해서 누르면 통증을 키울 수 있습니다 — 아프면 누르지 말고 바로 진료를 받으세요.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · ACR 적정성 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가장 정확한 검사는 복부 CT입니다

진찰·피검사와 함께 영상 검사로 확인합니다

98%

환자를 찾아내는 비율

CT의 민감도 — 병이 있을 때 찾아냄

97%

아닌 사람을 가려내는 비율

CT의 특이도 — 병이 없을 때 없다고 봄

96%

전체 정확도

CT로 맞게 진단하는 비율

복부 초음파는

민감도 약 85%, 특이도 90%, 정확도 83%로 CT보다 낮지만 **방사선이 없어** 임신부·어린이의 첫 검사로 씁니다.

영상만으로 100%는 아닙니다

진찰·피검사(백혈구·염증 수치)·증상 경과를 **함께 보고** 판단합니다.

Tip · 어떤 검사를 먼저 할지는 나이·임신 여부·증상 정도에 따라 의사가 정합니다.

근거 · WSES 예루살렘 지침 2020 · ACR 적정성 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

CT와 초음파, 어떻게 고를까요

환자 상황(나이·임신·증상 정도)에 따라 고릅니다

	복부 CT	복부 초음파
장점	가장 객관적이고 정확합니다. 터짐·고름주머니 확인에 좋습니다	방사선이 없어 임신부·어린이·반복 검사에 안전합니다
단점	방사선에 노출되고 조영제 알레르기가 있을 수 있습니다	비만·가스가 많으면 잘 안 보이고, 검사자에 따라 차이가 큽니다
먼저 쓰는 경우	성인, 심한 경우가 의심될 때	임신부·어린이, 빨리 확인이 필요할 때

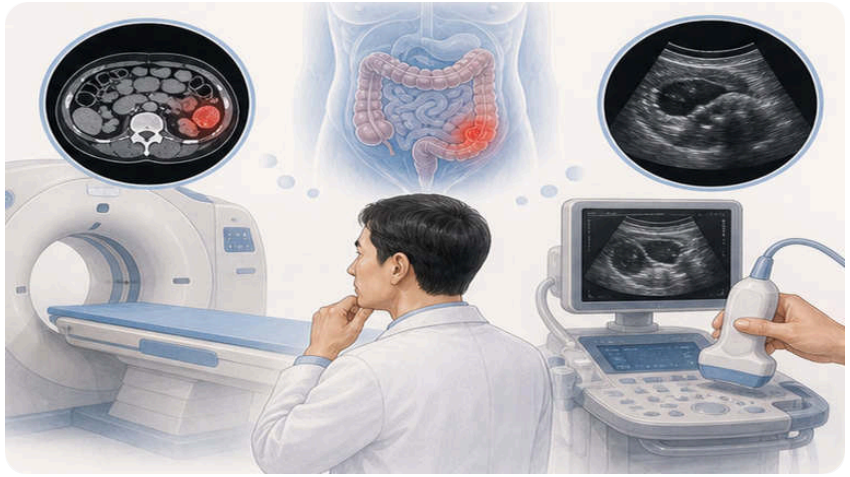


그림 · CT(왼쪽)와 초음파(오른쪽) — 상황에 맞는 검사를 고릅니다(설명용 그림).

Tip · 임신 가능성이 있으면 검사 전에 꼭 알려 주세요.

근거 · ACR 적정성 기준 · WSES 예루살렘 지침 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

의원 외래로 갈까, 응급실로 갈까

시간이 아니라 증상으로 판단합니다 — 응급실 칸의 신호가 하나라도 있으면 바로 응급실로 가세요

의원 외래 진료 가능

누를 때만 아프거나 가볍게 불편할 때

- 오른쪽 아랫배를 누를 때만 아픔(단순 압통)
- 명치·배꼽 주변이 가볍게 불편함
- 메스꺼움·미열이 없거나 약함
- 진찰·피검사·복부 초음파 → 결과에 따라 입원·수술 결정

vs

응급실로 가야 함

아래 중 하나라도 있을 때

- 눌렀다 뗄 때 더 아픔(반발 압통)
- 38°C 이상 열·오한
- 배가 단단해지거나 움직일 때 더 아파 걷기 어려움
- 응급실에서 진찰과 CT 등 영상 검사 여부를 바로 확인

Tip · 통증이 시작된 시각을 적어 두면 진료 때 판단에 큰 도움이 됩니다.

근거 · 광교바른내과 맹장염 안내문 · WSES 예루살렘 지침 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때는 바로 119 — 지체 없이 응급실로

배 안 전체에 염증이 번졌거나 장이 터졌다는 위험 신호입니다

⚠ 배가 판자처럼 딱딱해짐

배 전체가 굳으면 복막염 신호입니다. 터진 맹장·게실에서 장 내용물이 샌 상태입니다.

의식이 흐림 · 식은땀 · 맥이 빠름

전신 감염·쇼크 신호입니다. 혼자 두지 말고 **119 구급차**로 이동하세요.

통증이 잠깐 사라졌다 다시 심해짐

터지는 순간 통증이 줄었다가 배 전체로 퍼질 수 있습니다 — 좋아진 것이 아닙니다.

항문 출혈이 많음 · 검은 변

게실 출혈일 수 있습니다. 어지럽거나 쓰러질 것 같으면 119, 직접 운전하지 말고 금식합니다.

Tip · 이 신호는 기다리지 않습니다 — 직접 운전하지 말고 구급차를 부르세요.

근거 · WSES 복막염 지침 · 광교바른내과 맹장염 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

복통이 시작된 시각을 기억하세요

QR로 다시 보기 · 집에 가져가실 맹장염 신호 안내문, 검진에서 게실을 들었다면 대장 게실 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

갑작스러운 복통으로 걱정하시는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

WSES 예루살렘 지침 2020 · WSES 복막염 지침 · AGA 게실염 임상 업데이트 2021 · ACR 적정성 기준 · 대한외과학회 · 대한대장항문학회 · 광교바른내과 맹장염 안내문

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 맹장염 신호 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/abdominal-pain-appendicitis-red-flags/